

Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer

à tous les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, sociales et éthiques

Pr Laurent Zelek, Pr Guilhem Bousquet, Dr Boris Duchemann, Dr Eurydice Angeli

Service d'Oncologie, CHU Avicenne, AP-HP, Bobigny

OBJECTIFS : N° 295. Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, sociales et éthiques.

- Expliquer les principes de la prise en charge globale du malade à tous les stades de la maladie en tenant compte des problèmes psychologiques, éthiques et sociaux.
- Comprendre et intégrer la notion de discussion collégiale pour les prises de décision en situation de complexité et de limite des savoirs.

1. L'entrée dans la maladie : aspects psycho-sociaux, le dispositif d'annonce
2. La prise en charge personnalisée : du diagnostic à la surveillance
 - 2.1. Les grandes situations cliniques
 - 2.2. Le programme personnalisé de l'après-cancer
 - 2.3. Surveillance carcinologique et prévention tertiaire
3. La douleur en cancérologie
4. Des soins de support aux soins palliatifs
 - 4.1. Soins oncologiques de support
 - 4.2. Les soins palliatifs et l'arrêt des traitements actifs

Rang	Rubrique	Intitulé
A	Définition	Connaître les généralités sur la prise en charge en cancérologie
A	Prise en charge	Décrire le dispositif d'annonce
A	Définition	Connaître le Programme Personnalisé de Soins
A	Prise en charge	Connaître les modalités d'évaluation d'un patient cancéreux
A	Prise en charge	Connaître les grandes situations cliniques de prise en charge symptomatique
A	Prise en charge	Connaître la manière d'évaluer et de caractériser la symptomatologie douloureuse en cancérologie et la mise en place des modalités de traitement
B	Définition	Connaître la définition des soins de support en cancérologie
B	Prise en charge	Soins de support : connaître les grands principes de prise en charge des principales complications des traitements en cancérologie
B	Définition	Soins de support : connaître le concept de médecine alternative
B	Prise en charge	Connaître les phases du parcours de soins



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

A Introduction

- **Le parcours de soins d'un patient atteint d'un cancer est codifié.** Certains aspects font l'objet de dispositions réglementaires sous l'égide de l'Institut National du Cancer comme le « dispositif d'annonce » ou le « programme personnalisé de l'après-cancer ».
- **La possibilité de guérison de nombreux cancers est aujourd'hui élevée** et la survie des formes métastatiques peut se chiffrer en années. De ce fait, de nouveaux besoins doivent être pris en compte. Les soins de support ont une importance croissante à tous les stades de la maladie. Lors de la phase de surveillance, il convient d'intégrer au projet de soins une dimension globale de prise en charge de la personne (prévention tertiaire).
- **En cas de rechute**, les soins de support contribuent à améliorer la qualité de vie et à optimiser l'efficacité du traitement spécifique. Dans tous les cas, la dimension psycho-sociale doit être prise en compte.
- **D'un point de vue sociétal**, même si son image évolue, le cancer revêt une dimension particulière par rapport à d'autres pathologies chroniques engageant le pronostic vital. À la fin du XXe siècle, le militantisme associatif et la prise de conscience sociétale ont abouti à la mise en œuvre **en 2003 du premier Plan Cancer, suivi de la création de l'Institut National du Cancer (INCa) en 2005**. De ce fait, les cancers font partie des pathologies placées sous la responsabilité d'une agence sanitaire d'expertise au service de l'État. Outre ses missions liées à la recherche et à la formation, l'INCa contribue à l'organisation et à l'amélioration des soins et participe à la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la cancérologie comme le dispositif d'annonce ou le programme personnalisé de l'après-cancer.

À toutes les étapes de la maladie, il faut assurer la coordination entre les différents spécialistes et le lien entre les établissements de soins et « la ville ».

1. L'entrée dans la maladie : aspects psycho-sociaux

- Comme pour toute **annonce d'un diagnostic de maladie grave**, l'annonce du cancer est un traumatisme et marque l'entrée dans une vie où il faudra composer avec la maladie et ses traitements. Les images de mort et de souffrance, associées au cancer, aboutissent souvent à une sidération du patient qui ne pourra entendre le discours du médecin lors de la consultation initiale. Le besoin d'information du malade évolue secondairement et de nouveaux temps de discussion et d'explication permettront de délivrer une information, adaptée, personnalisée, progressive et respectueuse. Une information mieux vécue et comprise facilitera une meilleure adhésion du patient au projet thérapeutique et l'aidera à construire des stratégies d'adaptation face à la maladie.
- **Le programme personnalisé de soins (PPS)**, document écrit remis au patient au début de sa prise en charge, validé en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) et détaillant de façon personnalisée le(s) traitement(s) prévu(s), est la pierre angulaire du dispositif d'annonce.
- **Ce dispositif**, tel qu'il est défini par une circulaire officielle, **s'articule autour de quatre temps** :
 - **médical** : annonce du diagnostic, proposition de la stratégie thérapeutique ;
 - **soignant** : écoute du malade par une IDE d'annonce, reformulation de ce qui été dit pendant la consultation médicale, information sur le déroulement des soins et orientation vers d'autres professionnels ;
 - **accès aux soins de support** : prise en charge symptomatique et repérage des besoins spécifiques du patient notamment en terme psycho-social (soutien psychologie, associations de patients, évaluation de la précarité) ;
 - **articulation avec la médecine de ville** : le médecin traitant doit être informé en temps réel, en particulier dès le premier temps de la prise en charge hospitalière ; il reste un interlocuteur privilégié du patient et doit être associé au parcours de soins.

NB : LE DISPOSITIF D'ANNONCE S'APPLIQUE AUSSI AUX RECHUTES DE CANCER.

A 2. La prise en charge personnalisée : du diagnostic à la surveillance

2.1. Les grandes situations cliniques

- On distingue schématiquement trois types de situations :
 - **curative** : il s'agit essentiellement des cancers localisés et donc accessibles à un traitement local (principalement chirurgie, souvent associée à la radiothérapie ou parfois radiothérapie exclusive) ; il est possible en fonction du risque de rechute d'associer un traitement médical dit adjuvant (chimiothérapie ou hormonothérapie) destiné à réduire le risque ultérieur de métastases ;
 - **intermédiaire** : cas des maladies métastatiques pour lesquelles une survie prolongée (parfois plusieurs années) peut être obtenue au moyen de traitements médicaux, parfois associés à des traitements ablatifs (chirurgie, radiothérapie ou radiologie interventionnelle) des tumeurs lorsqu'elles sont peu nombreuses et accessibles ;
 - **palliatif** : il s'agit de maladies avancées où la place des traitements symptomatiques assurant le confort du patient et la qualité de vie est plus importante, alors que celle des traitements antitumoraux se réduit (ces derniers ayant pour but de participer au contrôle des symptômes).
- Il en résulte que le rapport bénéfice/risque des traitements varie au cours de l'évolution de la maladie : des traitements agressifs sont légitimes lorsqu'ils visent à augmenter les chances de guérison, ce qui n'est plus le cas lorsque la priorité est au contrôle des symptômes. Dans les derniers mois de vie, les traitements antitumoraux (chimiothérapie...) ne sont plus indiqués.
- Dans tous les cas, la prise en charge par les soins de support / soins palliatifs doit être proposée dès le diagnostic de maladie métastatique.

B 2.2. Le programme personnalisé de l'après-cancer

- Le **programme personnalisé de l'après-cancer (PPAC)** illustre les difficultés et enjeux d'une prise en charge multidisciplinaire.
- Ce document est remis au patient et adressé à son médecin traitant, il résume les éléments de la **consultation de suivi en cancérologie**, mais évalue aussi d'autres problématiques comme les **conséquences du cancer sur le maintien dans l'emploi**.
- Le contenu minimal d'un PPAC doit comprendre :
 - **un volet de surveillance médicale** : informations sur la maladie et les traitements reçus, leurs complications et modalités de surveillance ;
 - **un volet qualité de vie et accès aux soins de support** : soutien psychologique, soins esthétiques, conseils diététiques, pratique d'une activité physique adaptée, sevrage tabagique et des autres addictions ;
 - **un volet accompagnement social** : maintien dans l'emploi, ouverture de droits (dont reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), et reconnaissance des maladies professionnelles +++).

2.3. Surveillance carcinologique et prévention tertiaire

2.3.1. Diagnostic des récurrences

- Le **diagnostic précoce des récurrences n'est qu'un élément de la surveillance dont l'impact sur la survie est parfois contesté**. Par exemple, dans les cancers du sein et de l'ovaire, il est montré, avec un niveau de preuve élevé, que le diagnostic précoce des récurrences n'a pas d'impact sur la survie (la mise en œuvre plus précoce d'une chimiothérapie peut même être responsable d'une dégradation de la qualité de vie chez des malades asymptomatiques).

- **De ce fait les recommandations de surveillance sont minimalistes :**
 - **pour le cancer du sein :** mammographie annuelle et examen clinique tous les six mois pendant cinq ans puis tous les ans jusqu'à la dixième année ; les autres examens sont indiqués en fonction de la clinique ; le dosage systématique des marqueurs tumoraux N'EST PAS recommandé (HAS et recommandations internationales) ;
 - **pour le cancer de l'ovaire :** examen clinique tous les trois mois pendant deux ans puis tous les six mois jusqu'à la 5^e année avec dosage du CA 125 ; PAS d'imagerie chez les patientes asymptomatiques.
- **Dans d'autres cancers, comme le cancer du côlon** pour lequel il existe des possibilités de traitement chirurgical (ou ablatif, par exemple par radiofréquence) de certaines métastases, la surveillance est plus invasive avec un examen clinique, des dosages de marqueurs, et une imagerie à intervalles répétés auxquels il faut ajouter les coloscopies de surveillance à la recherche de nouveaux polypes ou d'une récurrence locale.

2.3.2. Prévention tertiaire

- Après le traitement d'un cancer se pose la question de la **prévention et du dépistage des seconds cancers**.
- La prévention tertiaire consiste, après le diagnostic, à agir sur les complications et les risques de récurrence :
 - dépister les seconds cancers et cibler leurs facteurs de risque (sevrage tabagique +++);
 - prévenir les complications iatrogènes ;
 - agir sur les facteurs de risque cardio-vasculaire : encourager la pratique de l'activité physique, réduire le surpoids ;
 - identifier les patients qui relèvent d'une consultation spécialisée en oncogénétique (soit parce que certains cas familiaux n'avaient pas été reconnus initialement, soit parce qu'ils sont survenus après le diagnostic chez le patient index).

A 3. La douleur en cancérologie

La recherche d'une symptomatologie douloureuse doit être systématique chez tout patient atteint de cancer, la douleur étant, avec la fatigue chronique, un des symptômes les plus fréquents.

- **L'évaluation de la douleur** repose sur l'interrogatoire, complété par l'auto-évaluation du patient sur une échelle visuelle analogique (EVA). Il faut, en particulier, préciser son caractère aigu ou chronique et son mécanisme d'action (excès de nociception, douleur neuropathique, douleur mixte), ainsi que son retentissement sur la qualité de vie (troubles du sommeil, dépression) (cf. Item n° 135 : Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses).
- **Les douleurs en cancérologie sont le plus souvent en rapport avec :**
 - **une atteinte tumorale :**
 - excès de nociception (ex. : métastase osseuse) ;
 - atteinte neuropathique (ex. : compression d'un tronc nerveux) ;
 - douleur mixte (ex. : envahissement pariétal thoracique).
 - **des séquelles des traitements :**
 - douleurs post-chirurgicales (souvent sur cicatrice, mais d'autres mécanismes sont possibles : par exemple, capsulite rétractile après curage axillaire) ;
 - douleurs post-chimiothérapies (essentiellement liées à certaines chimiothérapies responsables de neuropathies périphériques).
 - **il existe enfin une symptomatologie douloureuse propre à certaines atteintes neurologiques :**
 - céphalées de l'hypertension intracrânienne (HTIC) en cas de métastase(s) cérébrale(s) ;
 - méningites carcinomateuses qui sont responsables de symptômes neurologiques mal systématisés avec une composante neuropathique (un syndrome méningé « classique » est peu habituel dans ce contexte).

- La **prescription d'antalgiques** fait appel aux paliers 1 et 2 de l'OMS qui ont une efficacité rapidement limitée ; il faut alors recourir rapidement aux antalgiques de palier 3 (morphiniques).
- Les **co-antalgiques** sont également utiles dans certaines situations :
 - corticoïdes (prednisone 1mg/kg/j ou plus) en cas d'HTIC, de douleurs par compression ;
 - anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) dans les métastases osseuses (à utiliser avec prudence en raison des effets secondaires possibles chez ces patients fragiles) ;
 - inhibiteurs de la résorption osseuse (biphosphonates et dénosumab) qui ont surtout un effet préventif sur le risque fracturaire mais agissent aussi sur les douleurs osseuses ;
 - antibiotiques en cas de surinfection tumorale (pelvis, ORL) ;
 - topiques locaux pour certaines douleurs neuropathiques localisées.
- Il ne faut pas omettre la **radiothérapie antalgique** ainsi que certaines techniques de radiologie interventionnelle : cimentoplastie, radiofréquence ou embolisation.
- Il est recommandé de faire appel à un **médecin algologue** pour faire face aux douleurs complexes avec composante neuropathique.

A 4. Des soins de support aux soins palliatifs

- Les traitements antitumoraux sont une condition nécessaire mais non suffisante à une prise en charge optimale des patients. Il faut savoir **prescrire les soins associés à l'initiation d'une chimiothérapie** mais également **identifier, prendre en soin et suivre les patients en situation palliative**.
- La mise en place précoce des soins de support (puis des soins palliatifs) chez des patients non curables augmente non seulement la qualité de vie mais également la survie. La prise en charge symptomatique requiert l'intervention de plusieurs spécialistes (notamment des équipes spécialisées pour la prise en charge de la douleur).
- En complément de l'examen clinique des lésions tumorales, l'évaluation doit systématiquement préciser :
 - la symptomatologie douloureuse et la consommation d'antalgiques ;
 - l'évolution du poids, de l'appétit et la recherche des signes cliniques de dénutrition ;
 - l'indice d'activité (Performance Status – PS) selon l'échelle OMS/ECOG ou l'indice de Karnofsky (moins utilisé) (**Tableau 1**).

Tableau 1. INDICE D'ACTIVITÉ SELON L'ÉCHELLE OMS/ECOG

OMS/ECOG	Description
0	Asymptomatique (activité normale : aucune restriction à poursuivre les activités précédant l'affection)
1	Symptomatique (gêné pour les activités physiques soutenues mais capable de se déplacer seul et d'assurer un travail léger ou sédentaire, par exemple un travail de bureau ou le ménage)
2	Symptomatique, alité moins de 50 % de la journée (capable de se déplacer seul et de s'occuper de soi-même mais incapable de produire un travail léger)
3	Symptomatique, alité plus de 50 % de la journée, sans y être confiné (capable de prendre soin de soi-même de manière limitée, alité ou confiné au fauteuil plus de 50 % de la journée).
4	Confiné au lit (totalement dépendant, incapable de prendre soin de soi-même, confiné au lit ou au fauteuil).

B 4.1. Soins oncologiques de support

- Ils sont définis par l'INCa comme l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie, conjointement aux traitements onco-hématologiques spécifiques. Ils assurent la meilleure qualité de vie possible, et permettent de mieux prendre en charge les effets secondaires des traitements.
- Tous les patients atteints de cancer doivent avoir accès à des soins de support quel que soit le lieu de prise en charge. L'évaluation des besoins doit être réalisée dès l'annonce de la maladie et reconduite au cours de l'évolution ultérieure.
- Les symptômes suivants sont les plus fréquemment rencontrés et font appel à des mesures adaptées et spécifiques :

4.1.1. Nausées et vomissements chimio-induits (NVCi)

- Les **nausées** et **vomissements** sont des effets secondaires fréquents des chimiothérapies. On distingue les NVCi aigus, survenant au cours du traitement et dans les 24 premières heures après celui-ci, et les NVCi retardés survenant dans les jours qui suivent. Les NVCi aigus sont liées à l'activation de la voie sérotoninergique (récepteurs 5HT3) et sont prévenus par les anti-5HT3 (classe des sétrons) alors que les NVCi retardés sont liés à l'activation des récepteurs NK1, inhibés par les anti-NK1. Les sétrons ont une efficacité très limitée dans les NVCi retardés.
- Les chimiothérapies sont classées selon leur caractère émétogène (**Tableau 2**) :

Tableau 2. QUELQUES EXEMPLES DE MÉDICAMENTS SELON LEUR POTENTIEL ÉMÉTOGÈNE	
Potentiel émétogène des médicaments anticancéreux	
Élevé (> 90 %)	• Anthracyclines (et, en particulier, la bithérapie anthracycline–cyclophosphamide utilisée dans le cancer du sein) • Cisplatine
Modéré (30-90 %)	• Carboplatine • Oxaliplatine
Faible (10-30 %)	• Docétaxel • 5-Fluoro-uracile • Gemcitabine

- Les indications de traitement préventif peuvent être résumées comme suit :
 - risque élevé : Anti-5HT3 + Anti-NK1 + corticoïdes ;
 - risque modéré : Anti-5HT3 + corticoïdes ;
 - risque faible : antiémétique dopaminergique (ex. : métoclopramide) ou sétron seul.

NB : La prophylaxie doit être renforcée en cas de facteurs de risque aggravants individuels (anxiété, antécédents de NVCi).

4.1.2. Hématotoxicité

- Les chimiothérapies sont **toxiques sur les trois lignées sanguines**, et il faut connaître les particularités de l'**interprétation de l'hémogramme** en cancérologie :
 - la **neutropénie** est une complication fréquente qui est observée vers le J8 post-chimiothérapie. Elle est considérée comme sévère si les polynucléaires neutrophiles (PNN) sont $< 500/\text{mm}^3$ induisant un risque élevé de **fièvre** (on parle de neutropénie fébrile qui est une urgence oncologique) ;
 - l'**anémie** survient au cours des semaines suivant le début du traitement et est une cause fréquente d'**asthénie**. Elle est observée plus fréquemment avec certaines chimiothérapies (organoplatines). Elle est généralement multifactorielle car il s'y associe souvent une carence martiale et une composante inflammatoire ;

- la **thrombopénie** est plus rare dans le traitement des tumeurs solides qu'en hématologie. Elle survient un peu plus tardivement que la neutropénie, souvent après le J10 et peut nécessiter des transfusions plaquettaires (selon le contexte et le risque hémorragique, habituellement si les plaquettes sont $< 20\,000/\text{mm}^3$ ou en cas de saignement actif).
- La toxicité hématologique des chimiothérapies est une indication aux traitements symptomatiques :
 - **neutropénie** :
 - Prophylaxie primaire par G-CSF :
 - en cas de risque de neutropénie sévère $> 20\%$;
 - à discuter selon le contexte clinique (pathologies associées, sujet âgé, isolement...) en cas de risque compris entre 10 et 20 %.
 - Prophylaxie secondaire en cas de neutropénie $< 500/\text{mm}^3$ ou de neutropénie fébrile au cycle précédent.
 - **Anémie** :
 - **Dans tous les cas**, il faut au préalable dépister et corriger une carence martiale (dosage de la ferritinémie). Chez les patients traités pour cancer, les réserves en fer sont habituellement élevées (ferritinémie haute ou normale) du fait notamment du syndrome inflammatoire, sauf en cas de saignement chronique ou de chirurgie « lourde ». En cas de syndrome inflammatoire existe un défaut de mobilisation des réserves en fer se traduisant par une CST $< 20\%$ avec une ferritinémie élevée. La correction de la carence martiale se fait préférentiellement avec du fer IV (carboxymaltose ferrique) qui est plus commode, mieux toléré et plus rapidement efficace que le fer oral.
 - **En cas d'anémie mal tolérée** peut se discuter un traitement par érythropoïétine recombinante (EPO) ou une transfusion. L'EPO n'est pas indiquée chez les patients ne recevant pas de chimiothérapie ; son utilisation doit tenir compte de son rapport risque-bénéfice notamment en situation de curabilité car elle augmente légèrement le risque thromboembolique.
 - De façon schématique, l'EPO est instaurée lorsque l'Hb est $< 10\text{ g/dl}$ avec un taux cible de 12 g/dl (elle doit augmenter de 1 g/dl au bout d'un mois de traitement).
 - Les anémies sévères ($< 8\text{ g/dl}$) ont besoin d'être corrigées rapidement et sont des indications transfusionnelles.

ATTENTION : LA TOLÉRANCE DE L'ANÉMIE (et donc les indications d'EPO ou de transfusion) S'ÉVALUE CLINIQUEMENT +++ (une anémie à 8 g/dl d'installation progressive peut être bien mieux tolérée qu'une anémie à 9 g/dl d'apparition rapide).

4.1.3. *Fatigue chronique*

- L'**asthénie**, associée ou non à une anémie, est une plainte fonctionnelle majeure au même titre que la douleur. Elle concerne, suivant les localisations et les stades, 50 à 80% des patients.
- **Les causes curables** doivent être éliminées au premier rang desquelles figurent l'anémie et la carence martiale.
- **Les autres causes** qui doivent être recherchées sont :
 - un syndrome dépressif ;
 - une hypothyroïdie, classiquement fréquente après traitement d'un cancer du sein ou ORL ;
 - une altération du statut nutritionnel ou une carence vitaminique (ne pas oublier les carences en vitamine D qui sont fréquentes dans la population générale).
- Dans un grand nombre de cas, aucune cause évidente n'est retrouvée. La physiopathologie de ce syndrome reste mal comprise (syndrome inflammatoire, désadaptation à l'effort après une inactivité prolongée). Un programme d'activité physique adaptée peut apporter une amélioration significative.

4.1.4. Toxicités cutané-muqueuses

- Il s'agit essentiellement de l'alopecie, induite par certaines chimiothérapies, et de la mucite (inflammation des muqueuses +/- aphtes). Ces effets secondaires sont expliqués par l'effet des cytotoxiques sur les tissus à renouvellement rapide.
 - L'alopecie peut être prévenue dans certains cas par le port d'un casque réfrigérant pendant la séance de chimiothérapie ; il agit par le biais d'une vasoconstriction du cuir chevelu qui réduit la diffusion des cytotoxiques. Il ne faut pas oublier la prescription d'une prothèse capillaire dont une partie est prise en charge par les organismes de Sécurité Sociale.
 - Les mucites peuvent être sévères et gêner l'alimentation, ce qui contribue à la détérioration du statut nutritionnel. Elles sont prévenues par une hygiène bucco-dentaire rigoureuse (dans certains cas, notamment en cas de radiothérapie pour une tumeur ORL, des soins dentaires doivent être pratiqués avant de débiter le traitement) et par des bains de bouche bicarbonatés. Les aphtes sont généralement secondaires à une surinfection fongique sur une muqueuse fragilisée ; ils sont traités par des antifongiques locaux. Il ne faut pas méconnaître les récurrences herpétiques.
- Certains traitements, comme les inhibiteurs de l'*Epidermal Growth Factor Receptor* (EGFR) mais aussi d'autres thérapeutiques ciblées, peuvent être responsables de rash cutané, d'éruption acnéiforme, d'irritation palmo-plantaire ou de xérose cutanée. Pour ces patients, l'éducation thérapeutique est essentielle : choix des produits de toilette, application de crèmes émollientes. Certains services ont recours aux compétences d'une psycho-socio-esthéticienne ayant une formation spécifique pour ce type de situations.

4.1.5. Oncofertilité

- La préservation de la fertilité (recueil de sperme, congélation ovocytaire ...) doit être proposée avant tout traitement en particulier chez l'enfant et l'adulte jeune, à fortiori chez les patients n'ayant pas d'enfant.
- Les indications sont plus complexes chez la femme que chez l'homme car elles doivent tenir compte du type de cancer et de son projet thérapeutique ainsi que de l'âge de la patiente et de sa réserve ovarienne. La décision est prise en consultation d'oncofertilité, avec l'oncologue référent.
- Il n'est cependant pas possible de la réaliser dans certaines situations : urgence thérapeutique, état général altéré.

4.1.6. Médecines complémentaires et alternatives (MCA)

- Selon la terminologie de l'OMS, les MCA regroupent « des approches, des pratiques, des produits de santé et médicaux, qui ne sont pas habituellement considérés comme faisant partie de la médecine conventionnelle ». Certaines équipes (et de nombreux patients) y ont recours. On peut, par exemple, citer l'acupuncture ou l'auriculothérapie pour les NVCI. Certaines de ces thérapeutiques alternatives ont fait l'objet d'essais cliniques bien conduits et peuvent aider au contrôle de certains symptômes.
- Il faut être vigilant avec l'automédication, par exemple concernant des produits de phytothérapie qui peuvent être responsables d'interactions pharmacologiques (exemple classique du millepertuis), ainsi qu'avec les régimes restrictifs (« jeûne thérapeutique ») qui peuvent majorer la dénutrition.
- Dans des cas plus rares, des patients ont pu se détourner de traitements actifs pour privilégier des MCA d'utilité non démontrée.

A 4.2. Les soins palliatifs et l'arrêt des traitements actifs

- Les **situations palliatives** s'observent au cours de l'évolution des cancers avancés. Les soins palliatifs ont pour objet d'améliorer la qualité de vie, quel que soit le stade de la maladie, même en dehors des situations de fin de vie. Aussi, en phase métastatique, en dehors des derniers mois de vie, la distinction entre soins de support et soins palliatifs est parfois floue. Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés dans une approche globale. Leur objectif premier est de soulager les douleurs physiques mais ils prennent en compte les autres symptômes, y compris dans leur dimension de souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
- **L'accompagnement des patients en fin de vie se fait dans le respect des lois du 22/04/2005 (loi Leonetti) et du 02/02/2016 (loi Leonetti-Clays)** relatives aux droits des malades et de la fin de vie. Elles imposent le respect de la volonté de la personne en fin de vie (éventuellement par le biais de directives anticipées). Elles interdisent de provoquer délibérément la mort, mais prescrivent aux médecins de s'abstenir de poursuivre ou de mettre en œuvre des traitements « déraisonnables ». Lorsque la décision est prise d'interrompre ces traitements, les soins se poursuivent mais la priorité pour l'équipe médicale et soignante est d'apaiser la souffrance de la personne.
- **La décision de prise en charge palliative d'un patient pose la question de l'arrêt des traitements actifs**, notamment lorsqu'ils sont toxiques (chimiothérapies). Cependant, certains traitements antitumoraux peuvent être utiles même en situation palliative, comme par exemple la radiothérapie antalgique ou hémostatique. On admet qu'il ne faut pas proposer de traitement actif (en particulier chimiothérapie) aux patients dont l'espérance de vie est inférieure à 3 mois. Dans cette situation, une chimiothérapie est non seulement inefficace mais peut dégrader la qualité de vie, voire réduire la survie.
- **Les autres critères d'arrêt des traitements actifs sont :**
 - le souhait du patient ;
 - l'altération de l'état général (en pratique, si le PS OMS /ECOG est 3 ou 4) ;
 - le rapport risque/bénéfice paraît défavorable à la poursuite du traitement actif ;
 - l'inefficacité des traitements antérieurs.
- **Les soins palliatifs sont par essence pluridisciplinaires** et s'adressent tant au malade qu'à ses proches, à domicile ou en milieu hospitalier.
- **Ils peuvent être dispensés :**
 - dans les mêmes filières de soins que celles qui ont accueilli le patient au début de son parcours : par exemple, intervention d'une Équipe Mobile d'Accompagnement et de Soins Palliatifs dans un service d'oncologie ;
 - en milieu spécialisé : unité de soins palliatifs (USP) ; il existe aussi des lits identifiés dans les services cliniques, en dehors des USP ;
 - à domicile lorsque l'entourage et les conditions matérielles (logement...) le permettent.
- **Dans le cas de soins palliatifs à domicile**, le médecin traitant joue un rôle très important. Il peut s'appuyer sur plusieurs structures :
 - réseaux de soins palliatifs ou équipes d'appui pour le maintien à domicile des patients en soins palliatifs ;
 - Hospitalisation à Domicile (HAD) ;
 - lits ambulatoires de soins palliatifs qui sont encore rares mais commencent à apparaître dans certaines structures.

Principales situations de départ en lien avec l'item 295 :
« Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer
à tous les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs »

Situation de départ	Descriptif
327. Annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille	Bien retenir les modalités spécifiques à la cancérologie : organisation du dispositif d'annonce, et remise du programme personnalisé de soins (PPS).
En lien avec le suivi du patient en cancérologie	
297. Consultation du suivi en cancérologie	Les consultations de suivi n'ont pas pour seul but de détecter d'éventuelles récurrences. Il faut aussi corriger les facteurs de risque de seconds cancers ou d'autres maladies chroniques (tabac, sédentarité ...) et limiter les conséquences psycho-sociales de la maladie (maintien dans l'emploi).
316. Identifier les conséquences d'une pathologie/ situation sur le maintien d'un emploi	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	
En lien avec la douleur	
259. Évaluation et prise en charge de la douleur aiguë	La douleur en cancérologie a des mécanismes multiples. Sa prise en charge peut être complexe, faisant appel aux antalgiques de palier 3, aux co-antalgiques voire à certains gestes techniques (radiothérapie, radiologie interventionnelle, chirurgie des métastases osseuses).
260. Évaluation et prise en charge de la douleur chronique	
250. Prescrire des antalgiques.	
En lien avec les soins de support	
254. Prescrire des soins associés à l'initiation d'une chimiothérapie	Cette question aborde la gestion des effets secondaires des traitements et la prise en charge globale du patient.
13. Nausées/vomissements	Les nausées et vomissements chimio-induits sont des complications fréquentes des chimiothérapies et font appel à des traitements spécifiques.
223. Interprétation de l'hémogramme	La toxicité hématologique des chimiothérapies peut toucher les trois lignées.
44. Hyperthermie/fièvre	La fièvre peut compliquer une neutropénie chimio-induite, il s'agit d'une urgence qui requiert une antibiothérapie probabiliste sans attendre les résultats des prélèvements bactériologiques.
21. Asthénie	L'asthénie est fréquemment due à une anémie, mais la fatigue chronique est un syndrome multi-factoriel en oncologie.
En lien avec les soins palliatifs	
337. Identification, prise en soin et suivi d'un patient en situation palliative	Les soins palliatifs doivent être introduits le plus précocement possible dans l'évolution des cancers avancés (on parlera cependant plutôt de soins de support au début de la maladie métastatique).